# KI für Kodierprüfungen

## Nutzen für den Medizinischen Dienst

Prozesse, Kapazität und Wirtschaftlichkeit
unter der Annahme vollständiger Zuverlässigkeit

Deutschland · Daten 2025 · Stand 3. November 2026

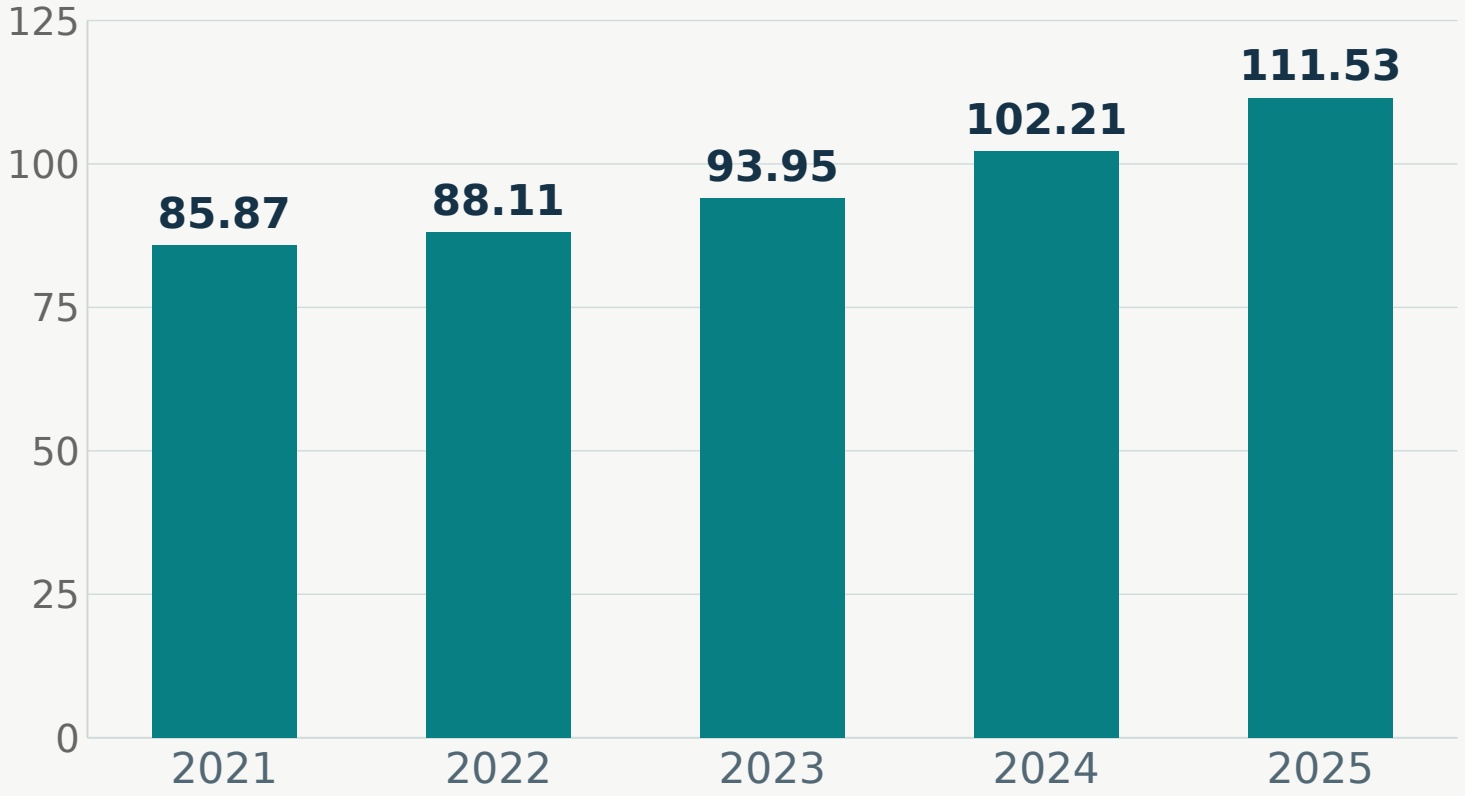


# Der größte direkte Nutzen liegt in der Prüfkapazität

| | |
|---|---|
| **Weniger Bearbeitungszeit** | Akten erschließen, Belege zuordnen und Begründungen vorbereiten. Fachpersonal gewinnt Zeit für komplexe Fälle. |
| **Einheitliche Bewertung** | Dieselbe Dokumentation und dieselbe Regelversion führen zu reproduzierbaren Ergebnissen. |
| **Weniger Nacharbeit** | Jede Feststellung enthält den Aktenbeleg, die anwendbare Regel und die konkrete Begründung. |
| **Wirtschaftlicher Einsatz** | Kapazität, tatsächlich vermeidbare Kosten und GKV-Rechnungskorrekturen bilden getrennte Nutzenkonten. |

Eigene Nutzenanalyse unter der Zuverlässigkeitsannahme.

# 111,53 Mrd. € GKV-Ausgaben für Krankenhausbehandlung




**+29,9 %**

nominaler Anstieg 2021 bis 2025

Eine korrekte Vergütung hat erhebliches finanzielles Gewicht.

[3] KJ 1. Ausgaben in Mrd. €, nominal. Eigene Veränderungsrechnung.

# Die Prüfungen bewegen bereits erhebliche Beträge

**1,24 Mrd. €**

rechnerische Differenzbeträge der GKV-Auswertung 2025

**53,7 %**

der DRG-Prüfungen beim MD: Abrechnung nicht korrekt

| Kennzahl | 2025 |
|---|---|
| MD: DRG-Prüfungen insgesamt | 1.185.314 |
| GKV: beanstandete Schlussrechnungen | 556.490 |
| GKV: mittlerer Differenzbetrag | 2.219,51 € |
| GKV: zusätzliche Aufschläge, separat | 183,1 Mio. € |

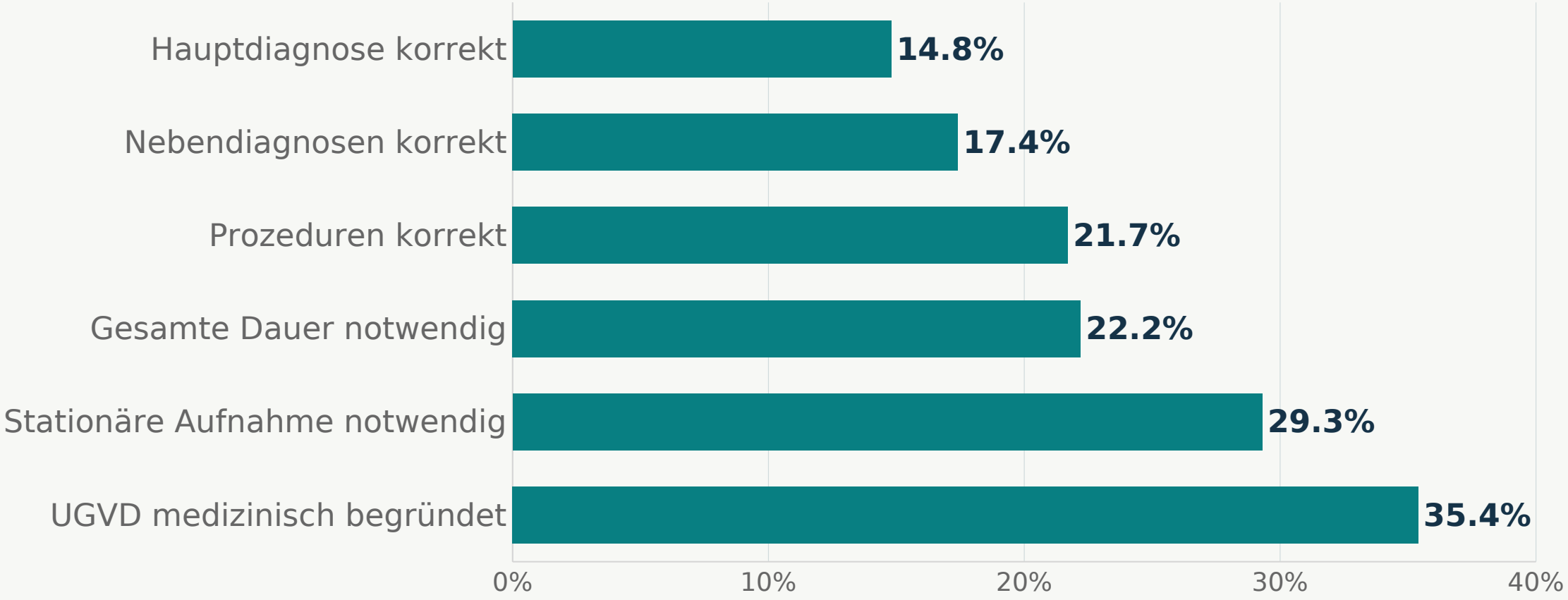
[1] MD: selektierte Prüffälle. [2] GKV 2025: eigene Betragsrechnung, vor späteren Streitkorrekturen. Definitionen siehe Folie 23.

# Prüfprozess: Rollen, Regelfristen und KI-Nutzen

| Schritt | Verantwortung / Regelfrist | Beitrag einer zuverlässigen KI |
|---|---|---|
| Auftrag | Kasse: direkt binnen 4 Monaten | Auftrag und Prüfumfang abgleichen |
| Anzeige / Unterlagen | MD: 2 Wochen. Klinik: 8 Wochen | Fristen und Vollständigkeit prüfen |
| Sachverhalt / Bewertung | MD: fachliche Begutachtung | Belege und Regeln zusammenführen |
| Entscheidung | Kasse: 9 Monate ab Prüfanzeige | Begründete Stellungnahme liefern |
| Erörterung | Kasse / Klinik: nach Bestreiten | Streitpunkte und Evidenz zuordnen |

[4–6] Regulärer Ablauf nach PrüfvV. Fristdetails und Ausnahmen hängen vom Fall ab.

# Verweildauerfragen prägen das Prüfvolumen




[1] Tab. 17, 2025. Anteil an 1.185.314 DRG-Prüfungen. Mehrfachfragen je Fall, daher keine Summe von 100 %.

# Konkreter Nutzen bei Kodierprüfungen

| Prüfgegenstand | KI-Leistung | Vorteil für den MD |
|---|---|---|
| Haupt- und Nebendiagnosen | Dokumentation und DKR abgleichen | Weniger manuelle Aktensuche |
| OPS und Mindestmerkmale | Jedes Merkmal mit Beleg prüfen | Vollständiger Merkmalsnachweis |
| Beatmung / Zeitmerkmale | Zeitachse aus Einträgen rekonstruieren | Weniger Übertragungs- und Rechenaufwand |
| Zusatzentgelte / Gruppierung | Mengen, Voraussetzungen und Ergebnis prüfen | Finanzielle Relevanz schneller erkennen |

[7–10] Fachliche Grundlagen. Nutzenwirkungen: eigene Analyse.

# Die Aktenauswertung unterstützt auch klinische Prüffragen

| | |
|---|---|
| **Aufnahmeindikation** | Behandlungsbedarf und tatsächlich erforderliche Krankenhausmittel aus der Akte belegen. |
| **Verweildauer** | Für jeden strittigen Tag Befunde, Maßnahmen und Gründe für eine stationäre Versorgung zusammenführen. |
| **PEPP** | Behandlungsaufwand, Therapieeinheiten und zeitbezogene Merkmale anhand der einschlägigen Regeln prüfen. |
| **Entlastung des Fachpersonals** | Eine belastbare Sachverhaltsgrundlage verkürzt Vorbereitung und begründende Dokumentation. |

[7] Prüfumfang DRG / PEPP. Potenzielle Wirkung unter der Zuverlässigkeitsannahme.

# Ein prüfbarer Evidenznachweis senkt die Nacharbeit

| Bestandteil | Ergebnis je Feststellung |
|---|---|
| Aktenbeleg | Dokument, Datum und genaue Fundstelle |
| Regelgrundlage | DKR / ICD / OPS mit passender Version und Geltung |
| Fachliche Begründung | Erfülltes oder fehlendes Kriterium im konkreten Fall |
| Abrechnungsfolge | Geprüfte Kodierung und nachvollziehbare Gruppierung |
| Freigabe und Verlauf | Verantwortliche Person, Änderungen und Zeitstempel |

[8–10, 15] Regel- und Begründungsanforderungen. Vorgeschlagenes Ausgabeformat.

# Frei werdende Zeit stärkt die vorhandene Expertise

**474,8 VZÄ**

Kodierfachkräfte in der MD-Gemeinschaft

**36,1 %**

des gutachterlichen GKV-Ressourceneinsatzes für Krankenhausleistungen

## Potenzielle Verwendung der Kapazität

Komplexe Begutachtungen, Qualitätssicherung und neue Prüfaufgaben. Einheitliche Wissensbasis erleichtert Einarbeitung und Vertretung.

[1] Personalstichtag 31.12.2025 und Ressourceneinsatz GKV 2025. Wirkungen: eigene Analyse.

# Schon Minuten je Fall ergeben relevante Kapazität

| Netto je Fall | Stunden/Jahr | Kapazität | Zeitwert bei 80 €/h |
|---|---|---|---|
| 10 Minuten | 158.042 | 99 VZÄ | 12,6 Mio. € |
| 20 Minuten | 316.084 | 198 VZÄ | 25,3 Mio. € |
| 30 Minuten | 474.126 | 296 VZÄ | 37,9 Mio. € |

**Kapazität ist ein betrieblicher Nutzen. Eine Budgetersparnis entsteht erst durch tatsächlich vermeidbare Ausgaben.**

Modell, keine gemessene KI-Wirkung. [1] DRG-Volumen 2025. Annahmen: 80 % Nutzung, 1.600 produktive Stunden/VZÄ.

# Beispiel für einen regionalen MD mit 100.000 Fällen

| Größe | Beispielwert |
|---|---|
| Jährliche Nettoentlastung | 26.667 Stunden = 16,7 VZÄ |
| Bewerteter Zeitgewinn | 2,13 Mio. € / Jahr |
| Laufende Zusatzkosten | 1,00 Mio. € / Jahr |
| Kapazitätswert nach laufenden Kosten | 1,13 Mio. € / Jahr |
| Einmalige Einführung | 1,50 Mio. € |

**Rund 16 Monate kapazitätsbasierte Amortisation ab vollem Hochlauf.**
**Die monetäre Amortisation hängt von der Realisierung des Zeitwerts ab.**

Planungsannahmen: 100.000 Fälle/Jahr, 80 % Nutzung, 20 Minuten Nettoentlastung, 80 €/h und 1.600 Stunden/VZÄ. Kosten ebenfalls angenommen.

# Die Wirtschaftlichkeit hängt von der Realisierung ab

| | |
|---|---|
| **Kosten der Einführung** | Schnittstellen, Datenaufbereitung, Vergabe, Validierung und Schulung. |
| **Kosten des Betriebs** | Lizenzen, Infrastruktur, Modellbetrieb, Regelpflege und laufende Qualitätssicherung. |
| **Finanzielle Realisierung** | Weniger Fremdleistungen, Mehrarbeit oder künftig nötige Neueinstellungen. |
| **Saubere Nutzenrechnung** | Zeitwert und Personalkosteneffekt nur einmal zählen. GKV-Erstattungen separat ausweisen. |

Eigene Wirtschaftlichkeitslogik. Keine veröffentlichten MD-internen Fallkosten oder KI-Preise unterstellt.

# GKV-Zusatzeffekte brauchen einen eigenen Nachweis

| Zusätzlicher Nettoanteil geminderter Fälle | Rechnerischer Differenzbetrag/Jahr |
|---|---|
| +0,5 Prozentpunkte | 12,6 Mio. € |
| +1,0 Prozentpunkt | 25,3 Mio. € |
| +2,0 Prozentpunkte | 50,5 Mio. € |

**Auch die Bestätigung korrekter Rechnungen schafft Wert.**
**Eine höhere Beanstandungsquote allein belegt keine bessere Prüfung.**

Illustrative Sensitivität. [2] 1.138.534 Gutachten 2025. Ein unveränderter mittlerer Differenzbetrag von 2.219,51 € ist unterstellt.

# Nachvollziehbare Gutachten können Streitaufwand senken

**126.655**

einzelfallbezogene Erörterungen 2025

**245 Mio. €**

geschätzte jährliche Personalkosten in Kliniken für MD-Prüfungen

## Potenzielle Wirkung

Klare Aktenbelege und eine konkrete Regelbegründung können Rückfragen, erneute Aktensichtung und Erörterungsaufwand verringern.

[2] GKV-Jahresstatistik 2025. [11] DKI-Hochrechnung 2026, Allgemeinkrankenhäuser ab 100 Betten.

# Die Vorteile verteilen sich auf mehrere Beteiligte

| Beteiligte | Potenzielle Vorteile | Passende Messgröße |
|---|---|---|
| Medizinischer Dienst | Mehr Kapazität, weniger Nacharbeit | Netto-Minuten und Kosten je Fall |
| Krankenkassen | Schnellere, belastbare Klärung | Endgültiger Netto-Differenzbetrag |
| Krankenhäuser | Weniger Such- und Streitaufwand | Bearbeitungszeit je Prüffall |
| Versicherte / Solidargemeinschaft | Effizientere Mittelverwendung | Reale Ressourcen und korrekte Leistungsgewährung |

**Der Versorgungsnutzen entsteht mittelbar durch den besseren Einsatz von Ressourcen.**

Eigene Wirkungsanalyse. Die monetären Wirkungen sind für jeden Beteiligten getrennt zu bilanzieren.

# Weitere Prüfaufgaben können dieselbe Basis nutzen

| Anwendung | Übertragbarer Nutzen | Zusätzliche Voraussetzung |
|---|---|---|
| OPS-Strukturen / Leistungsgruppen | Nachweise Kriterien zuordnen | Einrichtungsbezug und Vor-Ort-Evidenz |
| Qualitätskontrollen | Dokumente systematisch auswerten | Jeweilige G-BA-Anforderung |
| Abrechnung in der Pflege | Verordnung und Nachweis abgleichen | Eigene fachliche Prüfregeln |
| Systemberatung / Fortbildung | Wiederkehrende Streitfragen erkennen | Zulässige, möglichst aggregierte Datenbasis |

[1, 7] Aufgabenrahmen. Eigene Ableitung möglicher Anwendungen, jeweils mit eigener Validierung.

# Die Reformperspektive erhöht den Wert flexibler Kapazität

**98 %**

der befragten Kliniken erwarten ab 2027 höhere Prüfquoten.

**BMG-Mitteilung vom 10. Juli 2026**

Die beschlossene Reform sieht deutlich höhere Prüfquoten und Schwellenwerte vor.

**Für den MD: Lastspitzen mit standardisierter Aktenauswertung auffangen. Das tatsächliche Auftragswachstum bleibt offen.**

[11–12] Quellenstand 03.11.2026. Vor Anwendung zählt die gültige Fassung einschließlich Übergangsrecht.

# Auch ein zuverlässiges System braucht klare Verantwortung

| | |
|---|---|
| **Verantwortung** | Der MD verantwortet die fachliche Stellungnahme. Die Krankenkasse trifft die leistungsrechtliche Entscheidung. |
| **Sozialdatenschutz** | Zweckbindung, Zugriffsschutz und Datenminimierung gelten für Akte, Eingabe, Ausgabe und Protokolle. |
| **Nachvollziehbarkeit** | Versionierte Regeln, gespeicherte Evidenz und dokumentierte Freigabe sichern die Prüfbarkeit. |
| **Konkreter Verwendungszweck** | AI-Act-Einstufung und Automatisierungsgrad vor dem Einsatz fallbezogen bestimmen. |

[5, 13–15] Governance-Vorschlag. Rechtliche Einordnung nach dem konkreten Verwendungszweck.

# Der Nutzen entsteht in einer integrierten Anwendung

| Komponente | Erforderlicher Beitrag |
| --- | --- |
| Fallmanagement und eVV | Prüfauftrag, Dokumente und Fristen ohne Doppelerfassung |
| LLM / Dokumentenverarbeitung | Akteninhalt, Zeitachsen und Belege korrekt erschließen |
| Regelbestand und Grouper | Fassungen korrekt anwenden und Vergütung reproduzieren |
| Arbeitsplatz der Gutachtenden | Evidenz prüfen, Ausnahmen bearbeiten und freigeben |
| Betrieb und Nachweis | Zugriffe, Versionen, Qualität und Kosten überwachen |

[6, 8–10] Bestehende Standards und Regelquellen. Technisches Zielbild: eigener Vorschlag.

# Ein stufenweiser Einsatz macht den Nutzen messbar

| Phase | Nachweis vor dem nächsten Schritt |
|---|---|
| 1. Begrenzter Prüfumfang | Geeignete eindeutige Fälle und heutige Nettozeiten erfassen |
| 2. Retrospektive Prüfung | Ergebnisse gegen unabhängig adjudizierte Referenz prüfen |
| 3. Schattenbetrieb | Fehlende Dokumente, Fristen und Systemintegration testen |
| 4. Kontrollierter Betrieb | Zeitgewinn, Qualität und Zusatzkosten vergleichend messen |
| 5. Skalierung | Nur validierte Prüfarten und passende Regelversionen ausrollen |

Vorgeschlagenes Vorgehen. Zeitplan und Umfang hängen von Datenzugang und Integration ab.

# Die Entscheidung braucht wenige belastbare Kennzahlen

| Dimension | Messgröße | Entscheidungsrelevanz |
|---|---|---|
| Qualität | Fehlentscheidungen je Prüfart | Korrekte Bestätigung und Beanstandung |
| Produktivität | Netto-Minuten je geeignetem Fall | Echte Entlastung nach Kontrolle |
| Prozess | Durchlaufzeit und Nacharbeitsquote | Interne Zeit und Wartezeit trennen |
| Wirtschaftlichkeit | Gesamtkosten und realisierter Nutzen | Tragfähiger MD-Business-Case |
| Akzeptanz | Nutzung und fachliche Übersteuerung | Einbettung in die Begutachtung |

Vorgeschlagene Entscheidungsgrößen. Keine pauschalen Zielwerte oder Erfolgsquoten unterstellt.

# Annahmen und Bezugsgrößen

| | |
|---|---|
| **Zuverlässigkeit** | Korrekte Extraktion, Regelanwendung und Begründung im definierten Umfang. Fehlende Akten bleiben eine Informationsgrenze. |
| **Zwei Statistiken** | MD: fachliche Ergebnisse. GKV: leistungsrechtlich ausgewertete Schlussrechnungen. Die Fallzahlen sind nicht identisch. |
| **Modellgrenzen** | Zeitgewinn, Nutzungsgrad, Stundensatz und KI-Kosten sind Annahmen. Kapazität und Budgetwirkung unterscheiden sich. |
| **Finanzielle Bedeutung** | Rechnungskorrekturen sind Zahlungsverschiebungen. Reale Ressourceneffekte entstehen durch vermiedenen Aufwand. |

Methodenhinweise zu den Folien 4, 6, 10–15 und 18.

# Quellen 1 / 3


**[1] MD Bund: Tätigkeit und Personalausstattung 2024–2025**

Stand 01.06.2026. Tab. 2, 17–18, 25–26. S. 13, 54–56, 79–80.

**[2] GKV-Spitzenverband: Jahresstatistik 2025 nach § 17c KHG**

XLSX, bundesweit. Prüfergebnisse D20:I20, Erörterungen D19:G19.

**[3] GKV-Spitzenverband: GKV-Kennzahlen 2025**

Amtliche Statistik KJ 1. Krankenhausausgaben 2021–2025.

**[4] SGB V § 275c: Durchführung und Umfang der Prüfungen**

Konsolidierter, am 03.11.2026 abgerufener Text.

**[5] DKG / GKV-SV: Prüfverfahrensvereinbarung**

22.06.2021, ab Aufnahmen 01.01.2022. §§ 6–10.

**[6] DKG: Elektronische Vorgangsübermittlung mit dem MD**

eVV einschließlich technischer Anlage und Dokumententypen.


Alle Quellen abgerufen am 3. November 2026. Vollständige Fundstellen zusätzlich in den Foliennotizen.

# Quellen 2 / 3


**[7] MD Bund: Begutachtungsleitfaden DRG und PEPP 2025**

Prüfmethodik, Regelwerke und Prüfalgorithmen.

**[8] Medizinischer Dienst: SEG 4-Kodierempfehlungen**

Gesamtversion 01.01.2026, Einleitung zur Verbindlichkeit.

**[9] BfArM: OPS 2026, Kommentar zur Version**

Jährliche Fortschreibung von ICD-10-GM und OPS.

**[10] Selbstverwaltungspartner: Deutsche Kodierrichtlinien 2026**

Veröffentlicht beim GKV-Spitzenverband. Version 20.11.2025.

**[11] DKI: Blitzumfrage zu MD-Prüfungen, September 2026**

306 Krankenhäuser. Hochrechnung für Allgemeinkrankenhäuser ab 100 Betten. DKG-gefördert.


Alle Quellen abgerufen am 3. November 2026. Vollständige Fundstellen zusätzlich in den Foliennotizen.

# Quellen 3 / 3


**[12] BMG: Bundestag beschließt BStabG, 10.07.2026**

Mit Update zum Bundesrat. Abschnitt Krankenhaus, geänderte Prüfquoten.

**[13] MD Nordrhein: Was passiert mit meinen Daten?**

Sozialdatenschutz und KI-Unterstützung der Begutachtung.

**[14] EU-Kommission: AI Act Service Desk, Essential Services**

Abgrenzung natürlicher Personen und Kostenerstattung an Unternehmen.

**[15] SGB V § 275: Begutachtung und Beratung**

Abs. 5 und 6: Unabhängigkeit und Begründung der Stellungnahme.

**[16] Bildnachweis: Lindner Group, Klinikum Nordstadt 2a**

Foto des Krankenhausflurs auf dem Titel. Dekorative Verwendung.


Alle Quellen abgerufen am 3. November 2026. Vollständige Fundstellen zusätzlich in den Foliennotizen.